מתן גלוקגון בהיפוגליקמיה

שלומית אטלו

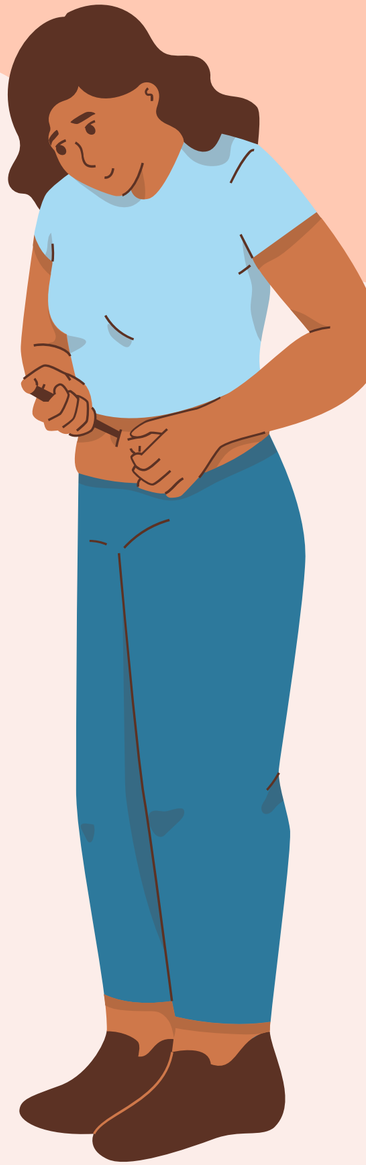
הגדרות

- היפוגליקמיה חמורה - ערכי סוכר מתחת ל-54 והמטופל מחוסר או מעורפל הכרה
- גלוקגון - הורמון הגורם לפירוק גליקוגן מהכבד והפיכתו לגלוקוז

סמכות למתן בהיפוגליקמיה

- רופא
- אחות מוסמכת לאחר הכשרה במערכת TEACH, במצב של היפוגליקמיה מסכנת חיים

טיפול בהיפוגליקמיה חריפה



למטופל עירוי מרכזי	למטופל עירוי פריפרי	כאשר אין רופא או אין למטופל עירוי
מתן גלוקוז 20% 50 מ"ל בפוש לוריד מרכזי, ע"י רופא בלבד, ולאחר מכן הזלפה איטית של גלוקוז 5%	מתן גלוקוז 10% -100 150 מ"ל בהזלפה מהירה, בהוראת רופא, ולאחר מכן הזלפה איטית של גלוקוז 5%	מתן גלוקגון IM 1mg להכניס עירוי ולהזליף באופן איטי גלוקוז 5%

התוויות למתן

- היפוגליקמיה **מסכנת חיים**
- אין עירוי פתוח
- מטופל לא יכול לקבל טיפול פומי

התוויות נגד

- מחלת כבד כרונית
- הרעלת אלכוהול
- רגישות יתר לגלוקגון
- פאוכרומוציטומה
- זהירות בהריון והנקה

ככלל, עדיף לתת **גלוקוז לוריד** מאשר גלוקגון

לא יעיל למטופל בצום / היפוגליקמיה כרונית- במצב זה אין מאגרי גליקוגן בכבד

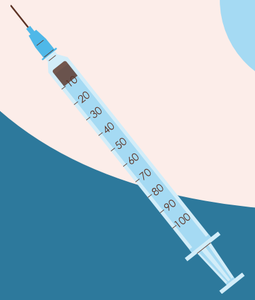
התוויות למתן ע"י אחות
(ללא הוראת רופא)

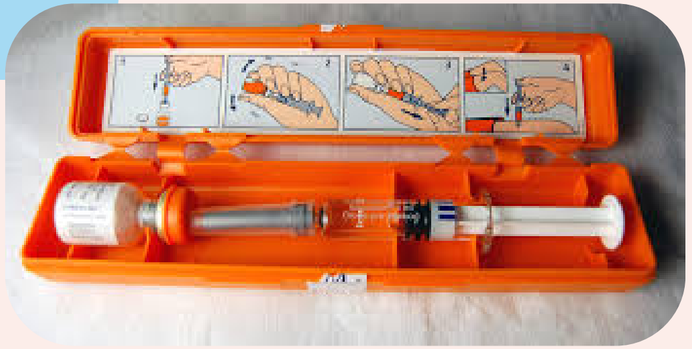
- שקיעה הכרתית
- סוכר נמוך מ - 70 מ"ג/ד"ל

- ניתן לתת את התרופה פעם אחת בלבד!
- שיפור במצב המטופל צפוי להופיע כ- 10-15 דק' מזמן מתן התרופה
- לאחר התעוררות המטופל יש לתת פחמימה לשמירה על ערכי סוכר יציבים
- יש לברר את סיבת ההיפוגליקמיה

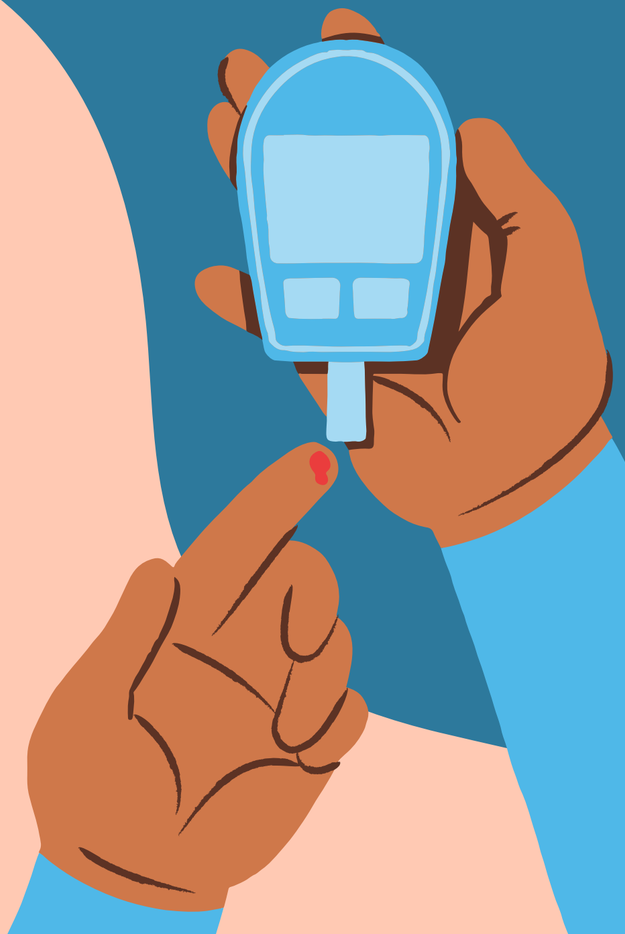
אופן הכנת התרופה

- מינון התרופה 1 מ"ג למבוגר וילד מעל 25 ק"ג
- יש לתת את התרופה IM או SC
- התרופה מגיעה בערכה כתומה ונמצאת במגירה של תרופות IV
- יש להכניס את התמיסה לבקבוקון, לערבב ולשאוב את התרופה





תופעות לוואי



בחילות והקאות
כאבי בטן
כאבי ראש
היפר גליקמיה
פריחה דמוית סטיבן ג'ונסון
ירידה ברמת האשלגן

גלוקגון בהרעלת בטא בלוקרים.

- בהרעלת בטא בלוקרים גלוקגון ניתן כטיפול **סימפטומיטי**
- הטיפול הוא במתן IM או SC
- במקרה של שוק קרדיוגני הטיפול הוא במתן IV במספר מנות במינונים מוגברים על פי הצורך **ולפי הוראת רופא**
- חשוב לציין - על המזרק רשום כי ניתן לתת את התרופה IM או SC בלבד אך במקרה ורופא מבקש לתת את התרופה IV יש לתת לו את המזרק **ושהרופא ייתן את התרופה**.
- רזרבה של התרופה בבית חולים נמצאת במכון **גסטרו**

בהצלחה!